

# GUIA DE ESTUDO

## Manejo odontológico do paciente com TEA nível 3, TDAH e TAG

*III Simpósio de Pacientes com Necessidades Especiais — V JOCAM*

Conteúdo do banner, organizado para estudo. As dez partes vão do diagnóstico ao manejo; a Parte 11 é a revisão rápida para ler na véspera.

## PARTE 1 — AS TRÊS CONDIÇÕES

### 1.1 Transtorno do Espectro Autista (TEA)

Distúrbio do neurodesenvolvimento que afeta de forma persistente duas áreas: a comunicação e a interação social, e o padrão de comportamento, que se torna restrito e repetitivo. O diagnóstico é clínico, pelo DSM-5-TR, e não existe exame laboratorial que o confirme.

O DSM-5 classifica em três níveis, pelo quanto de apoio a pessoa precisa:

| Nível | Denominação                   | O que significa na prática                                                                                                                                    |
|-------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Exige apoio                   | Fala, mas tem dificuldade de iniciar interação; inflexibilidade atrapalha a rotina. Costuma colaborar no consultório com manejo básico.                       |
| 2     | Exige apoio substancial       | Fala limitada a frases curtas; comportamentos repetitivos evidentes; sofrimento claro com mudanças.                                                           |
| 3     | Exige apoio muito substancial | Comunicação verbal mínima ou ausente; extrema dificuldade em lidar com mudança; comportamentos restritos que interferem em tudo. É o nível da nossa paciente. |

O que mais importa para a Odontologia é o quarto item dos critérios: a hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais. Luz, ruído, cheiro, sabor e toque podem ser sentidos de forma muito mais intensa. É isso que transforma a cadeira odontológica — luz do refletor, ruído da alta rotação e do sugador, cheiro de eugenol, toque na boca — num ambiente hostil.

*Prevalência: o CDC (relatório de 2025, ano de vigilância 2022) identificou TEA em 1 a cada 31 crianças de 8 anos nos EUA, contra 1 em 36 no levantamento anterior.*

### 1.2 Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)

Também é transtorno do neurodesenvolvimento. Caracteriza-se por desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade em grau que prejudica a vida da criança. Tem três apresentações:

- Predominantemente desatenta — não sustenta atenção, parece não ouvir, perde coisas.
- Predominantemente hiperativa-impulsiva — não para quieta, interrompe, age sem pensar.
- Combinada — as duas, é a mais comum.

No consultório, o TDAH aparece como dificuldade de permanecer na cadeira, de aguardar e de seguir instrução sequencial. Em casa, aparece como dificuldade de manter rotina de escovação.

### **1.3 Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG)**

Preocupação excessiva e difícil de controlar, por pelo menos seis meses, acompanhada de sintomas como inquietação, irritabilidade, tensão muscular e alteração de sono. Na criança a ansiedade raramente é verbalizada: aparece como irritabilidade, queixas físicas (dor de barriga, dor de cabeça), choro, recusa e comportamento de fuga.

No atendimento, o efeito é a antecipação: a criança já chega em estado de alerta esperando que algo ruim aconteça, antes mesmo de qualquer procedimento.

### **1.4 Por que as três juntas pioram o quadro**

Não é soma, é multiplicação. O TEA traz a dificuldade de comunicação e a hipersensibilidade; o TDAH impede permanecer parada e seguir instruções; o TAG faz a criança chegar já alerta. Cada um ataca um pilar diferente do manejo comportamental — e o manejo depende dos três.

A coexistência é comum, não é exceção:

- Metanálise de 2019 na Lancet Psychiatry: TDAH em 28% das pessoas com TEA e transtornos de ansiedade em 20%. Em amostras clínicas, como a de uma clínica de PNE, as taxas são bem maiores.
- Quando há os dois diagnósticos, o protocolo precisa contemplar os dois: previsibilidade e suporte visual pelo TEA, consulta curta e objetiva pelo TDAH.

## PARTE 2 — O QUE ISSO CAUSA NA BOCA

Ponto que a banca adora: a condição em si não causa cárie. O que causa é a cadeia de fatores que vem junto. Saiba enumerar os cinco.

### 2.1 Risco aumentado de cárie e doença periodontal

| Fator                          | Por quê                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Higiene dependente do cuidador | A criança não escova sozinha de forma eficaz. A qualidade da higiene é a qualidade da escovação que o cuidador consegue fazer — e ele nem sempre foi orientado. |
| Hipersensibilidade oral        | O toque da escova é aversivo. A criança recusa, o cuidador desiste, o biofilme se acumula.                                                                      |
| Seletividade alimentar         | A recusa de textura leva a dieta pastosa, repetitiva e muitas vezes açucarada, com alta frequência de ingestão.                                                 |
| Hipossalivação medicamentosa   | Psicofármacos reduzem o fluxo salivar, e com ele a capacidade tampão e a autolimpeza.                                                                           |
| Dificuldade de acesso          | Consultas desmarcadas, profissionais sem treinamento, diagnóstico tardio — a lesão é descoberta já extensa.                                                     |

*Dado para citar: metanálise de Drumond et al. (2022) mostrou que crianças com TDAH têm razão de chances de 3,31 (IC 95% 1,25–8,73) para cárie em relação às sem o transtorno.*

### 2.2 Os medicamentos e a boca

| Classe / exemplo                                    | Para quê                              | Repercussão bucal                                                        |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Psicoestimulantes — metilfenidato, lisdexanfetamina | TDAH                                  | Xerostomia, bruxismo, redução de apetite e alteração do padrão alimentar |
| Antipsicóticos atípicos — risperidona, aripiprazol  | Irritabilidade e agressividade no TEA | Alteração do fluxo salivar, ganho de peso, sedação                       |
| ISRS — sertralina, fluoxetina                       | Ansiedade                             | Xerostomia e bruxismo                                                    |

Pergunte sempre qual medicamento a criança usa, a dose e o horário. O horário importa: uma consulta marcada no pico do estimulante pega a criança mais focada.

### 2.3 Outras alterações frequentes

- Bruxismo — comum, agravado por estimulantes e por ansiedade; leva a desgaste e sensibilidade.
- Traumatismo dentário — mais frequente por alterações motoras, impulsividade e crises.
- Autolesão — mordedura de lábio, língua e mucosa em alguns pacientes com TEA nível 3.
- Respiração bucal e sialorreia em parte dos casos, com repercussão em gengivite.
- Erosão — se houver refluxo ou ruminação, que ocorrem em parte dos pacientes.

## PARTE 3 — COMO AVALIAR ANTES DE TRATAR

### 3.1 A anamnese ampliada

É o que diferencia o atendimento. Além da anamnese comum, pergunte ao responsável:

- Como a criança se comunica? Fala, aponta, usa prancha, usa aplicativo, puxa pela mão?
- Qual é a rotina dela? Em que horário ela está melhor?
- O que a incomoda? Luz forte, barulho, cheiro, toque, ser segurada, espera?
- O que a acalma? Objeto preferido, música, vídeo, um brinquedo específico?
- Como é a escovação em casa? Quem faz, quanto tempo, em que posição, com qual creme?
- Como é a alimentação? Quais texturas aceita, com que frequência come, o que bebe?
- Já foi a dentista antes? Como foi? O que deu errado?
- Quais medicamentos usa, em que dose e horário? Faz terapia? Com qual equipe?

*Essas respostas definem o horário da consulta, quem vai atender, o que vai ser mostrado primeiro e o reforço que será usado. Não é formalidade: é o plano de tratamento.*

### 3.2 Escala de Frankl

Classificação clássica do comportamento infantil na cadeira, usada em quase todos os estudos da área. Saber de cor pega bem:

| Grau | Classificação            | Comportamento                                                   |
|------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1    | Definitivamente negativo | Recusa o tratamento, chora intensamente, resiste fisicamente    |
| 2    | Negativo                 | Relutante, pouco cooperativo, retraído                          |
| 3    | Positivo                 | Aceita o tratamento com reservas, segue orientações com cautela |
| 4    | Definitivamente positivo | Bom vínculo, interessado, colabora plenamente                   |

### 3.3 O cuidador é parte da equipe

No paciente com TEA nível 3 o cuidador é tradutor, co-terapeuta e termômetro. Ele interpreta os sinais da criança, executa a higiene em casa e sustenta a rotina entre as consultas. A permanência dele na sala reduz a ansiedade, e orientá-lo rende mais resultado do que qualquer procedimento isolado.

## PARTE 4 — MANEJO BÁSICO

A diretriz da American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD) divide o manejo em básico e avançado. O básico vem primeiro, sempre. É o conteúdo central do banner.

### 4.1 Previsibilidade — o princípio que organiza tudo

Para quem tem TEA, o imprevisto é a maior fonte de estresse. Então:

- Consultas curtas. Melhor três sessões de 15 minutos do que uma de 45.
- Sempre no mesmo horário, de preferência no período em que a criança está melhor.
- Sempre na mesma sala ou box, com a mesma equipe. Trocar o operador pode zerar o progresso.
- Primeira consulta apenas de adaptação, sem procedimento. Parece perda de tempo; é o que faz a segunda consulta acontecer.
- Avisar antes cada etapa, na mesma ordem, toda vez.

### 4.2 Dessensibilização progressiva

Aproximação gradual e repetida do que causa aversão. A criança entra na sala, senta na cadeira, sobe e desce a cadeira, vê o espelho, encosta o espelho na mão, depois na bochecha, depois na boca. Cada etapa é repetida até ser tolerada antes de avançar para a seguinte. Programas de dessensibilização se mostraram superiores à abordagem convencional de orientação comportamental em estudos da área.

### 4.3 Dizer-mostrar-fazer e perguntar-dizer-perguntar

- Dizer-mostrar-fazer (tell-show-do): explicar em linguagem acessível, demonstrar na mão da criança ou num modelo, e só então executar. No TEA nível 3 a parte do "dizer" se apoia na imagem, não na fala.
- Perguntar-dizer-perguntar (ask-tell-ask): checar o que a criança entendeu antes e depois de explicar. Útil quando há alguma comunicação verbal.

### 4.4 Pedagogia visual

O recurso com melhor evidência no TEA. Usa imagens em sequência para antecipar o que vai acontecer, substituindo a instrução verbal:

- Agenda visual — a sequência da consulta em figuras, que a criança acompanha e vai retirando.
- Pranchas de comunicação — a criança aponta o que sente ou o que quer.
- PECS (Picture Exchange Communication System) — sistema de comunicação por troca de figuras.
- TEACCH — método de ensino estruturado que organiza espaço, tempo e tarefa por pistas visuais.
- Histórias sociais — narrativa ilustrada da visita ao dentista, lida em casa antes.

*Metanálise de Balian et al. (2021): a pedagogia visual melhora a cooperação durante o atendimento e a qualidade da escovação.*

### 4.5 Modelagem por vídeo

A criança assiste, em casa, a um vídeo curto de alguém passando pelo procedimento — de preferência outra criança, ou ela mesma em consulta anterior. Chega ao consultório sabendo o que vai acontecer.

*Ensaio clínico randomizado brasileiro, de Da Silva Moro et al. (2024): a modelagem por vídeo reduziu o número de consultas necessárias para o atendimento não invasivo.*

#### **4.6 Reforço positivo**

Elogio descritivo e recompensa imediata a cada etapa cumprida — não só no fim. "Você abriu a boca, muito bem" vale mais que "você foi bem hoje". A recompensa deve ser algo que importa para aquela criança, definido com o cuidador na anamnese.

#### **4.7 Ambiente sensorialmente adaptado**

Reduzir a carga sensorial da sala:

- Luz — diminuir o refletor, oferecer óculos escuros.
- Som — abafador de ruído ou fone com música calma; evitar conversa cruzada na sala.
- Cheiro — evitar eugenol e produtos de odor forte.
- Tato — colete com peso ou cobertor pesado, que dá sensação de contenção calmante.
- Visual — retirar do campo de visão os instrumentos que não serão usados.

*Cermak et al. (2015), estudo piloto com 44 crianças, e Stein Duker et al. (2023), ensaio cruzado com 162 crianças autistas: o ambiente adaptado reduziu o estresse fisiológico, medido no corpo da criança, em todas as fases da consulta, além do sofrimento comportamental.*

## PARTE 5 — MANEJO AVANÇADO

Entra quando o básico não é suficiente. Nunca é a primeira escolha, e sempre exige consentimento informado e registro em prontuário.

### 5.1 Estabilização protetora

Restrição do movimento para proteger a criança e a equipe durante o procedimento. Regras:

- Só quando necessário, nunca por conveniência ou pressa.
- Sempre a técnica menos restritiva que permita atender com segurança.
- Com consentimento informado dos riscos, benefícios e alternativas, inclusive a de não tratar ou adiar.
- Registrada em prontuário: indicação, tipo, duração e resposta do paciente.
- Nunca como punição, e nunca sem supervisão contínua.

### 5.2 Sedação

Vai da sedação mínima com óxido nitroso e oxigênio até a sedação moderada e profunda. Exige profissional habilitado, monitorização e estrutura de emergência. Útil quando o procedimento é necessário, a criança não tolera, mas não se justifica a anestesia geral.

### 5.3 Anestesia geral

Em ambiente hospitalar. Indicada quando há grande necessidade de tratamento, impossibilidade de manejo e risco de o adiamento agravar o quadro. Resolve a demanda acumulada numa sessão, mas não ensina a criança a aceitar o atendimento — por isso o condicionamento continua depois.

### 5.4 A escada — como responder se perguntarem a ordem

1. Manejo básico e prevenção. 2. Adaptação do ambiente. 3. Dessensibilização em várias sessões. 4. Sedação mínima. 5. Estabilização protetora, se indicada. 6. Sedação moderada ou profunda. 7. Anestesia geral. Sobe-se um degrau por vez, e só quando o anterior falhou.

## PARTE 6 — PREVENÇÃO: O QUE REALMENTE MUDA O DESFECHO

Quanto mais prevenção, menos necessidade dos degraus de cima. É a tese da conclusão do banner.

- Escovação supervisionada pelo cuidador, com técnica orientada e posição definida — a posição joelho a joelho, ou a criança deitada com a cabeça no colo do cuidador, funciona bem.
- Escova elétrica — útil quando a higiene depende de terceiros; em alguns pacientes a vibração é aversiva, então teste antes.
- Creme dental fluoretado em quantidade adequada à idade; se a criança não cospe, usar quantidade reduzida.
- Verniz fluoretado em aplicações periódicas — rápido, bem tolerado e de alto impacto.
- Selantes nos molares, quando houver cooperação.
- Diamino fluoreto de prata — paralisa a lesão de cárie sem preparo cavitário, sem ruído e sem anestesia. Escurece a lesão, o que precisa ser explicado e consentido.
- Tratamento restaurador atraumático (ART) — remoção com instrumento manual e restauração com ionômero, sem alta rotação.
- Orientação dietética focada em frequência, não só em quantidade.
- Retornos curtos e frequentes, que mantêm o vínculo e o condicionamento.

# PARTE 7 — DIREITOS E LEGISLAÇÃO

| Norma                                                                          | O que garante                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lei 12.764/2012 — Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA | Considera a pessoa com TEA como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, com direito a atendimento integral em saúde.          |
| Lei 13.977/2020 — Lei Romeo Mion                                               | Cria a Carteira de Identificação da Pessoa com TEA (CIPTEA), que dá acesso a atendimento prioritário.                                      |
| Lei 13.146/2015 — Lei Brasileira de Inclusão                                   | Define os tipos de barreira (urbanística, arquitetônica, de transporte, de comunicação, atitudinal e tecnológica) que devem ser removidas. |
| Guia de Atenção à Saúde Bucal da Pessoa com Deficiência (MS, 2019)             | Orienta a rede SUS sobre manejo e cuidado, com capítulo sobre TEA.                                                                         |

# PARTE 8 — AS EVIDÊNCIAS DO BANNER NUMA TABELA

| Referência                  | Tipo de estudo                      | O que mostrou                                                                  |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| AAPD (2024)                 | Diretriz                            | Separa manejo básico de avançado e define quando escalar                       |
| Balian et al. (2021)        | Revisão sistemática com metanálise  | Pedagogia visual melhora cooperação e higiene bucal                            |
| Stein Duker et al. (2023)   | ECR cruzado, 162 crianças           | Ambiente adaptado reduz estresse fisiológico e comportamental                  |
| Cermak et al. (2015)        | ECR piloto, 44 crianças             | Mesma linha, primeiro estudo do tema                                           |
| Da Silva Moro et al. (2024) | ECR, autores brasileiros            | Modelagem por vídeo reduz o número de consultas                                |
| Drumond et al. (2022)       | Metanálise                          | Cárie em TDAH: OR 3,31 (IC 95% 1,25–8,73)                                      |
| AlBhaisi et al. (2022)      | Revisão sistemática                 | Técnicas psicológicas funcionam, mas a evidência é inconclusiva quanto à força |
| Bezerra et al. (2023)       | Revisão de literatura, em português | Panorama nacional do atendimento à criança com TEA                             |

*A referência mais forte do conjunto é Stein Duker (2023). A mais fácil de ler inteira é Bezerra (2023), em português e gratuita. Leia essa primeiro.*

## **PARTE 9 — PERGUNTAS DE BANCA, COM RESPOSTA**

### **Por que não sedar logo, já que a paciente não colabora?**

Porque a AAPD coloca sedação e anestesia geral como manejo avançado, para depois da falha do básico. Além do risco e do custo, a sedação resolve a consulta mas não ensina a criança a aceitar o atendimento. O condicionamento tem efeito duradouro.

### **Por que a criança com TEA tem mais cárie?**

Não é a condição em si. É a soma de higiene dependente do cuidador, hipersensibilidade oral que dificulta a escovação, dieta seletiva e cariogênica e hipossalivação causada pelos psicofármacos.

### **O que muda no atendimento por ser nível 3 e não nível 1?**

No nível 3 a comunicação verbal é mínima, então todo o manejo se apoia em recurso visual e em rotina, não em explicação falada. E a alteração sensorial costuma ser mais intensa, o que torna a adaptação do ambiente indispensável, não opcional.

### **Qual a diferença entre estabilização protetora e imobilização?**

Estabilização protetora é indicada, consentida, registrada em prontuário e feita na técnica menos restritiva possível. Imobilização sem indicação e sem consentimento é conduta inadequada.

### **A pedagogia visual funciona mesmo ou é teoria?**

A metanálise de Balian mostra melhora de cooperação e de higiene bucal. A limitação é que os estudos são pequenos e heterogêneos, como o próprio AlBhaisi aponta.

### **Como vocês lidariam com a hipersensibilidade na hora da escovação?**

Dessensibilização gradual do toque, começando fora da boca; escova de cerdas macias e cabeça pequena; testar escova elétrica, que ajuda em parte dos casos e piora em outros; posição joelho a joelho; e creme sem sabor forte, porque o sabor é um gatilho frequente.

### **O TDAH muda alguma coisa no manejo, ou é só o TEA?**

Muda. O TDAH exige consulta curta e objetiva, com poucas instruções por vez, e aumenta o risco de cárie por falha de rotina de higiene e por impulsividade alimentar. É ele que justifica sessões de 15 minutos em vez de 45.

### **E a ansiedade, como vocês abordam?**

Com previsibilidade. A ansiedade generalizada faz a criança antecipar o pior, então saber exatamente o que vai acontecer, na mesma ordem, com a mesma equipe, é o que reduz a antecipação. Vídeo e agenda visual em casa atacam exatamente isso.

### **Qual recurso vocês implantariam amanhã na clínica?**

Agenda visual impressa e vídeo gravado com o celular. Custo quase zero, e são justamente os dois com ensaio clínico mostrando ganho de cooperação e redução do número de consultas.

### **Se nada funcionar, o que vocês fazem?**

Mantemos a adequação do meio bucal e o controle preventivo, e escalamos conforme a necessidade e a urgência: sedação e, se indicado, anestesia geral, sempre com consentimento e em conjunto com a família e com o médico que acompanha a criança.

### **Vocês citam que não existe protocolo único. Então o que o trabalho conclui?**

Que a conduta é individualizada, mas os princípios são constantes: anamnese ampliada, previsibilidade, suporte visual, adaptação sensorial, reforço positivo e prevenção. O que varia é a combinação e o ritmo, não os princípios.

**Por que a primeira consulta sem procedimento não é perda de tempo?**

Porque o custo de uma primeira consulta malsucedida é a recusa nas seguintes. A consulta de adaptação constrói o vínculo que permite todas as outras — é investimento, não desperdício.

## PARTE 10 — GLOSSÁRIO

| Termo                     | Significado                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| DSM-5-TR                  | Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 5ª edição, texto revisado |
| Dessensibilização         | Exposição gradual e repetida ao estímulo aversivo até que seja tolerado            |
| Dizer-mostrar-fazer       | Explicar, demonstrar e só então executar                                           |
| Pedagogia visual          | Uso de imagens em sequência para antecipar e organizar o procedimento              |
| PECS                      | Sistema de comunicação por troca de figuras                                        |
| TEACCH                    | Método de ensino estruturado por pistas visuais de espaço, tempo e tarefa          |
| Modelagem por vídeo       | Assistir a alguém passando pelo procedimento antes de vivê-lo                      |
| Escala de Frankl          | Classificação do comportamento infantil na cadeira, de 1 a 4                       |
| Estabilização protetora   | Restrição de movimento indicada, consentida e registrada                           |
| ART                       | Tratamento restaurador atraumático, sem alta rotação                               |
| Diamino fluoreto de prata | Agente que paralisa a lesão de cárie sem preparo cavitário                         |
| Xerostomia                | Sensação de boca seca, geralmente por redução do fluxo salivar                     |
| CIPTEA                    | Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista             |

## PARTE 11 — REVISÃO DE DEZ MINUTOS

Para ler antes de apresentar. Se você souber estes dez pontos, sustenta qualquer conversa sobre o banner.

1. TEA nível 3 é o que exige apoio muito substancial: comunicação verbal mínima, comportamento repetitivo e alteração sensorial.
2. A alteração sensorial é o que mais importa na Odontologia: luz, ruído, cheiro e toque são sentidos de forma intensificada.
3. TDAH impede permanecer parada e seguir instrução; TAG faz a criança chegar já em alerta. Os três juntos derrubam a colaboração.
4. O risco de cárie não vem da condição: vem de higiene dependente do cuidador, hipersensibilidade oral, dieta seletiva e boca seca por medicamento.
5. Metanálise de 2022: crianças com TDAH têm OR 3,31 para cárie.
6. A anamnese ampliada é o plano de tratamento: rotina, comunicação, gatilhos, reforços, medicamentos.
7. Previsibilidade é o princípio central: consulta curta, mesmo horário, mesma sala, mesma equipe, primeira sessão só de adaptação.

8. O condicionamento é gradual: dessensibilização, dizer-mostrar-fazer, pedagogia visual, vídeo e reforço positivo a cada etapa.
9. O ambiente adaptado reduz estresse fisiológico comprovadamente — ECR com 162 crianças, 2023.
10. Contenção, sedação e anestesia geral só depois da falha do básico, com consentimento. E a prevenção é o que evita chegar lá.